

БЕКИТЕМ

Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
алдындагы Дары каражаттары
жана медициналык буюмдар
департаментинин
директорунун орун басары

Кысанов Т.А.

«26»

декабрь

2024-ж.

ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА

ЛЕСОН

Соодадагы аталышы: Лесон.

Эл аралык патенттелбеген аталышы: левоцетиризин + монтелукаст.

Дарынын түрү: жука чел кабык менен капталган таблеткалар.

Курамы: жука чел кабык менен капталган ар бир таблетка төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдүү заттар:

Левоцетиризин дигидрохлориди USP 5 мг

Натрий монтелукаст ВР

10 мг монтелукастка туура келет

Көмөкчү заттар: микрокристаллдуу целлюлоза, жүгөрү крахмалы, лактоза, повидон, натрий бензоаты, магний стеараты, тазартылган тальк, натрий крахмалгликолят (А тиби), суусуз колоиддүү кремний диоксиди;

Жука чел кабыгы: Cotab RFC ак, титан диоксиди.

Сүрөттөмөсү: Жылмакай, эки жагы томпок, тегерек формадагы, ак түстөгү жука чел кабык менен капталган таблеткалар.

Фармадарылык тобу: Респиратордук системанын ооруларын дарылоо үчүн препараттар. Дем алуу жолдорунун бүтөлмө ооруларын дарылоо үчүн препараттар. Системалуу колдонуу үчүн дем алуу жолдорунун бүтөлмө ооруларын дарылоо үчүн башка препараттар. Лейкотриен рецепторлорунун антагонисттери. Монтелукаст башка препараттар менен айкалышта.

АТХ коду: R03DC53.

Фармакологиялык таасири:

Фармакодинамикасы:

Левоцетиризин – цетиризиндин энантиомери, гистаминдин атаандаш антагонисти, цетиризинге караганда жакындыгы 2 эсеге жогору H_1 -гистамин рецепторлорун бөгөйт.

Гистаминге көз каранды баскычындагы аллергиялык реакцияларга таасир көрсөтөт, эозинофилдердин миграциясын, кан тамыр өткөргүчтүгүн азайтат, сезгенүү медиаторлорунун бошонуусун чектейт. Аллергиялык реакциялардын өрчүүсүн алдын алат жана жеңилдетет, антиэкссудативдик, кычышууга каршы таасир көрсөтөт, дээрлик антихолинергиялык жана антисеротониндик таасир көрсөтпөйт. Дарылык дозаларда тынч алдыруучу таасири абдан аз. Бир жолку дозаны ичкенден кийин таасири 50 % бейтаптарда 12 минутадан кийин, 95 % - 1 сааттан кийин башталат жана 24 саат бою уланат.

Монтелукаст – дем алуу жолдорунун эпителийинин цистеинил лейкотриен рецепторлорун басаңдатат, аны менен бир убакта колко астмасы бар бейтаптарда цистеинил-лейкотриен LTD4 менен дем алуусуна шартталган колко карышуусун басаңдатуу жөндөмдүүлүгүнө ээ болот. LTD4 пайда болгон колко карышуусун токтотуу үчүн 5 мг дозасы жетиштүү. Бир жолу колдонулуучу күнүнө 10 мг.дан ашкан дозаларда монтелукастты колдонуу препараттын натыйжалуулугун жогорулатпайт. Монтелукаст ичкенден кийин 2 саат ичинде бронходилатацияны пайда кылат; жана β_2 –адреномиметиктерден пайда болгон бронходилатацияны кошумчалашы мүмкүн.

Фармакокинетикасы:

Левоцетиризин – ичкенден кийин препарат ашказан-ичеги жолунда тез жана толук сиңирилет. Тамак ичүү толук сиңирүүгө таасир бербейт, бирок анын ылдамдыгы азаят. Чоң адамдарда препаратты дарылык дозада (5 мг) бир жолу ичкенден кийин кан плазмасындагы эң жогорку концентрациясына (C_{max}) 0,9 сааттан кийин жетет жана 270 нг/мл, суткасына 5 мг дозаны кайталап ичкенден кийин - 308 нг/мл түзөт. Концентрациянын туруктуу деңгээлине 2 суткадан кийин жетет.

Левоцетиризин кан плазма белоктору менен 90% га байланышат. Бөлүштүрүү көлөмү (V_d) 0,4 л/кг түзөт. Биожеткиликтүүлүгү 100% га жетет.

Зат алмашуу. Фармакологиялык активдүү эмес метаболитти пайда кылуу менен организмде N- жана O-деалкирилөө (цитохромдор системасынын жардамы менен боордо зат алмашуучу Hг гистаминдик рецепторлордун башка антагонисттеринен айырмаланып) жолу менен бир аз өлчөмдөрдө (<14 %) зат алмашат. Зат алмашуу төмөн деңгээлде жана метаболикалык потенциалы жок болгондуктан левоцетиризиндин башка дары препараттары менен өз ара таасири күмөн. Чоң адамдарда жарым-жартылай бөлүп чыгаруу мезгили ($T_{1/2}$) ($7,9 \pm 1,9$) саатты түзөт; кичинекей балдарда $T_{1/2}$ кыска. Чоң адамдарда жалпы клиренси 0,63 мл/мин/кг түзөт. Препараттын кабыл алынган дозасынын 85,4 % жакыны түйдөкчөлүү чыпкалоо жана түтүкчө секрециясы жолу менен өзгөрүлбөгөн түрдө бөйрөктөр аркылуу бөлүнүп чыгат; 12,9 % жакыны – ичеги аркылуу.

Бөйрөк алсыздыгы бар бейтаптарда (креатинин клиренси (КК) <40 мл/мин) препараттын клиренси азаят, ал эми ($T_{1/2}$) узарат (ошентип, гемодиализде турган оорулууларда жалпы клиренси 80% га төмөндөйт), бул дозалоо режиминде тиешелүү өзгөртүүнү талап кылат. Левоцетиризиндин 10% дан азы гемодиализдин 4 сааттык стандарттуу процедурасынын жүрүшүндө жоголот.

Монтелукаст ичкенден кийин тез жана дээрлик толук сиңирилет. Кадимки тамакты ичүү биожеткиликтүүлүккө жана жука чел кабык менен капталган таблеткалардын плазмадагы эң жогорку концентрациясына (C_{max}) таасир бербейт. Чоң адамдарда 10 мг чел кабык

капталган таблеткаларды ачкарын ичүүдө Стах 3 сааттан кийин жетет. Ичүүдө биожеткиликтүүлүгү 64% ды түзөт.

Монтелукаст кандын плазма белоктору менен 99% көбүрөөк байланышат. Монтелукасттын бөлүштүрүү көлөмү орточо 8-11 литрди түзөт. Монтелукаст боордо активдүү зат алмашат. Дарылык дозаларын колдонууда чоң адамдарда жана балдарда тең салмактуу абалда плазмада монтелукасттын метаболиттеринин концентрациясы аныкталбайт. Монтелукасттын зат алмашуу процессине P450 CYP (3A4 жана 2C9) цитохромунун изоферменттери катышары божомолдонот, мында монтелукасттын дарылык концентрацияларында P450 CYP цитохром изоферменттери: 3A4, 2C9, 1A2, 2A6, 2C19 жана 2D6 басаңдатпайт.

Монтелукасттын клиренси дени сак чоң адамдарда орточо 45 мл/мин түзөт. Монтелукастты пероралдуу ичкенден кийин анын өлчөмүнүн 86% 5 күн ичинде заң жана 0,2% азыраагы заара менен бөлүнүп чыгат, бул монтелукаст жана анын метаболиттери өт менен гана бөлүнүп чыгарын далилдейт.

Жаш дени сак чоң адамдарда монтелукастты жарым-жартылай бөлүп чыгаруу мезгили 2,7ден 5,5 саатка чейинди түзөт. 50 мг жогору дозаларда ичүүдө монтелукасттын фармакокинетикасы дээрлик сызыктуу мүнөздү сактайт. Монтелукастты эртең менен жана кечки сааттарда ичүүдө фармакокинетикасында айырмалар байкалган эмес. Суткасына 1 жолу 10 мг ичүүдө плазмада активдүү заттын орточо топтолуусу (14% жакын) байкалган.

Колдонууга көрсөтмөлөр:

- жыл бою жана мезгилдик аллергиялык риниттин (анын ичинде туруктуу аллергиялык ринит) жана аллергиялык конъюнктивиттин симптомдорун, чүчкүрүүнү, ринореяны, жаш агууну, конъюнктиванын кызаруусун дарылоо;
- колко астмасын алдын алуу жана узакка дарылоо.

Каршы көрсөтмөлөр:

- препараттын курамындагыларга жогорку сезгичтик;
- креатинин клиренси 10 мл/мин аз болушу менен оор бөйрөк алсыздыгы;
- галактозага көтөрүмсүздүк, лактаза Лаппа жетишсиздиги, глюкоза жана галактоза мальабсорбциясы синдрому;
- 15 жашка чейинки балдар курагы;
- кош бойлуулук жана бала эмизүү мезгили.

Этияттык менен: өнөкөт бөйрөк алсыздыгы (дозалоо режимин тууралоо талап кылынат); улгайган курак (түйдөкчөлүү чыпкалоо төмөндөшү мүмкүн); жүлүндүн жабыркоолору, эрендик бездин гиперплазиясы бар бейтаптар, ошондой эле зааранын кармалышына жакындатуучу башка факторлордун болушунда; алкоголь менен бир убакта ичүүдө.

Кош бойлуулук жана бала эмизүү мезгили:

Кош бойлуулукта монтелукастты жана левоцетиризинди колдонуунун коопсуздугуна адекваттуу жана катуу көзөмөлдөнгөн клиникалык изилдөөлөр жүргүзүлгөн эмес. Ошентип, кош бойлуу аялдарда левоцетиризин + монтелукаст айкалышын колдонуу каршы көрсөтүлөт. Левоцетиризин жана монтелукаст эне сүтүнө өтөрү белгисиз. Ошондуктан бала

эмизүү мезгилинде препаратты колдонуу зарылдыгында эне сүтүн эмизүүнү токтотуу сунушталат.

Колдонуу жолу жана дозалары:

Тамак ичүүгө карабастан суткасына 1 жолу ичип колдонулат.

Чоң адамдар жана 15 жаштан жогорку курактагы балдар:

Чоң адамдар жана 15 жаштан жогорку курактагы балдар үчүн дозасы суткасына 1 таблетканы түзөт. *Колко астмасын дарылоо* үчүн Лесонду кечинде кабыл алуу керек. *Аллергиялык ооруларды дарылоодо* дозаны бейтаптын каалоосу боюнча сутканын ар кандай убагында кабыл алууга болот.

Жалпы сунуштар:

Колко астмасынын өтүшүн чагылдырган көрсөткүчтөргө Лесон препаратынын дарылык таасири биринчи күндүн ичинде өрчүйт. Бейтапка Лесонду колко астмасынын симптомдорун көзөмөлдөөгө жеткен мезгилде дагы, ошондой эле колко астмасы курчуган мезгилде дагы колдонууну улантуу керек. Улгайган бейтаптар, боор функциясынын жеңил же орточо оор бузулуулары бар бейтаптар үчүн, ошондой эле жынысына жараша дозасын атайын тандоо талап кылынбайт.

Бөйрөк алсыздыгы бар бейтаптар: Орточо бөйрөк алсыздыгы (креатинин клиренси >79 мл/мин) бар бейтаптар үчүн дозасын тууралоо талап кылынбайт. Орточо жана оор бөйрөк алсыздыгы (креатинин клиренси <79 мл / мин $\rightarrow$ 10 мл/мин) бар бейтаптар үчүн препаратты этияттык менен жана катуу медициналык байкоо алдында колдонуу керек.

Препаратты ичүүнүн узактыгы

Мезгилдик (мезгил-мезгили менен кармаган) ринитти (симптомдордун жумасына 4 күндөн аз болушу же алардын жалпы узактыгы 4 жумадан аз) дарылоодо дарылоонун узактыгы оору белгилеринин узактыгына жараша болот; симптомдору жоголгондо дарылоо токтотулушу жана симптомдору пайда болгондо кайра улантылышы мүмкүн.

Жыл бою (туруктуу) аллергиялык ринитти (симптомдордун жумасына 4 күндөн ашык болушу же алардын жалпы узактыгы 4 жумадан көп) дарылоодо аллергия таасир берген бардык мезгил ичинде дарылоо улантылышы мүмкүн. Препаратты бир ичүүнү өткөрүүдө өткөрүлгөн ичүүнү толуктоо үчүн препараттын кошумча дозасын кабыл алууга болбойт, кийинки дозаны адаттагы убагында ичүү сунушталат.

Кыйыр таасирлери:

Төмөндө саналган жагымсыз көрүнүштөр төмөнкү градацияга ылайык пайда болуу жыштыгы боюнча бөлүштүрүлгөн: абдан тез-тез ($\geq 1/10$); тез-тез ($\geq 1/100$ ден $<1/10$ чейин); тез-тез эмес ($\geq 1/1000$ ден $<1/100$ чейин); сейрек ($\geq 1/10000$ ден $<1/1000$ чейин); абдан сейрек ($<1/10000$); жыштыгы белгисиз (болгон маалыматтар боюнча жыштыгын саноого мүмкүн эмес).

Монтелукаст.

Кан жана лимфа системасы тарабынан: жыштыгы белгисиз — кан агууга жогору жакындык, тромбоцитопения.

Иммундук система тарабынан: сейрек — жогорку сезгичтик реакциясы, а.и. анафилаксия, абдан сейрек — боордун эозинофилдик инфильтрациясы.

Психиканын бузулуусу: жыштыгы белгисиз — ажитация, а.и. агрессивдүү жүрүм-турум же душмандуулук, коркуу, чүнчүү, багытын жоготуу, жаман түш көрүүлөр, галлюцинациялар, уйкусуздук, кыжырдануу, тынчсыздануу, элирме, суициддик ойлор жана жүрүм-турум (өзүн өлтүрүү), титирөө, көңүл буруунун жана эс-тутумдун бузулушу.

Нерв системасы тарабынан: сейрек — баш оору, баш айлануу, уйкусууроо; абдан сейрек — карышуулар; жыштыгы белгисиз — сезүүнүн бузулуусу/гипестезия.

Жүрөк тарабынан: жыштыгы белгисиз — жүрөктүн тез-тез согушу.

Дем алуу системасы, көкүрөк клеткасынын органдары жана орто көңдөй тарабынан: сейрек — мурундан кан агуу, жыштыгы белгисиз — жогорку дем алуу жолдорунун инфекциялары, фарингит, жөтөл, синусит, ринорея, Чардж-Стросс синдрому.

Ашказан-ичеги жолу тарабынан: сейрек — зарна, кекирүү, ичтин оорушу; жыштыгы белгисиз — ич өтүү, кусуу, диспепсия, окшуу, ич катуу, панкреатит, ооздун кургашы.

Боор жана өт бөлүп чыгаруу жолдору тарабынан: сейрек — кандын сары суусунда боор трансаминазасынын активдүүлүгүнүн жогорулашы (АЛТ, АСТ), абдан сейрек — гепатит (анын ичинде холестатикалык, гепатоцеллюлярдык жана боордун аралаш жабыркоолору).

Тери жана тери алдындагы ткандар тарабынан: сейрек — тери бөртмөсү, бөрү жатыш; жыштыгы белгисиз — ангионевротикалык шишимик, экхимоздун пайда болуусу, түйүндүү эритема, көп түрдүү эритема, теринин кычышуусу.

Скелеттик-булчуң системасы жана байланыштыргыч ткандар тарабынан: сейрек — артралгия; жыштыгы белгисиз — миалгия, анын ичинде булчуңдардын карышуусу.

Бөйрөк жана заара бөлүп чыгаруу жолдору тарабынан: жыштыгы белгисиз — балдарда заараны кармай албоо.

Жалты бузулуулар жана куйган жердеги бузулуулар: сейрек — астения (алсыроо)/чарчоо; жыштыгы белгисиз — шишимиктер, пирексия, суусоо.

Левовоцетиризин.

Иммундук система тарабынан: жыштыгы белгисиз — жогорку сезгичтик реакциялары, а.и. анафилактикалык реакциялары.

Зат алмашуу жана тамактануу тарабынан: жыштыгы белгисиз — табиттин жогорулашы, дене салмагынын жогорулашы.

Психиканын бузулуусу: тез-тез — баш оору, уйкусууроо, чарчоо; тез-тез эмес — астения; жыштыгы белгисиз — коркуу, агрессия, дүүлүгүү, уйкусуздук, галлюцинациялар, чүнчүү, суициддик ойлор.

Нерв системасы тарабынан: жыштыгы белгисиз — карышуулар, мээнин катуу чел кабыгынын синустарынын тромбозу, сезимдин бузулушу, баш айлануу, эси ооп калуу, титирөө, дисгевзия (даам сезүүнүн бузулушу).

Көрүү органы тарабынан: жыштыгы белгисиз — көрүүнүн бузулуусу, кош көрүнүү, сезгенүү, бүдөмүк көрүү.

Угуу органы тарабынан жана лабиринттик бузулуулар: жыштыгы белгисиз — вертиго.

Жүрөк тарабынан: жыштыгы белгисиз — тахикардия, стенокардия, жүрөктүн согушун сезүү.

Кан тамырлар тарабынан: жыштыгы белгисиз — моюнтурук тамырдын тромбозу.

Дем алуу системасы, көкүрөк клеткасынын органдары жана орто көңдөй тарабынан: жыштыгы белгисиз — демигүү, риниттин симптомдорунун күчөшү.

Ашказан-ичеги жолу тарабынан: тез-тез — ооздун кургашы; тез-тез эмес — ичтин оорушу; жыштыгы белгисиз — окшуу, ич өтүү, кусуу.

Боор жана өт бөлүп чыгаруу жолдору тарабынан: жыштыгы белгисиз — гепатит.

Тери жана тери алдындагы ткандар тарабынан: жыштыгы белгисиз — ангионевротикалык шишимик, туруктуу дарылык эритема, бөртмө, кычышуу, бөрү жатыш, гипотрихоз, жаракалар, фотосенсибилизация.

Скелеттик-булчуң системасы жана байланыштыргыч ткандар тарабынан: жыштыгы белгисиз — булчуңдардын оорусу, артралгия.

Бөйрөк жана заара бөлүп чыгаруу жолдору тарабынан: жыштыгы белгисиз — дизурия, зааранын кармалышы, заара ушатууга чакыруу.

Лабораториялык жана инструменталдык маалыматтар: жыштыгы белгисиз — боордун функционалдык сынамдарынын өзгөрүүсү.

Башкалар: жыштыгы белгисиз — кайчылаш реактивдүүлүк, четки шишимиктер.

Эгерде нускамада көрсөтүлгөн кыйыр таасирлердин ичинен кайсы бири күчөсө, же нускамада көрсөтүлбөгөн ар кандай башка кыйыр таасирлери байкалса, бул тууралуу дарыгерге билдирүү керек.

Ашыкча доза:

Левоветиризин

Симптомдору: уйкусуроо, балдарда — тынчсыздануу, кыжырдануу

Дарылоо: ашказанды жууп тазалоо, активдешкен көмүрдү ичүү, оору белгилерине жараша дарылоо.

Атайын антидоту жок, гемодиализ натыйжасыз.

Монтелукаст

Симптомдору: суусоо сезими, уйкусуроо, мидриаз, гиперкинездер жана ичтин оорушу.

Дарылоо: оору белгилерине жараша.

Монтелукастты перитонеалдык диализ же гемодиализ жолу менен чыгаруу мүмкүндүгү тууралуу маалыматтар жок.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасири:

Левоецетиризин.

Рацемат цетиризинди феназон, псевдоэфедрин, циметидин, кетоконазол, эритромицин, азитромицин, глипизид жана диазепам менен дарылык өз ара таасирин изилдөөдө клиникалык маанилүү жагымсыз өз ара таасирлери аныкталган эмес. Теофиллин (суткасына 400 мг) левоецетиризиндин жалпы клиренсин 16%га төмөндөтөт, мында теофиллиндин кинетикасы өзгөрүлбөйт. Изилдөөдө ритонавирди (600 мг суткасына 2 жолу) жана цетиризинди (суткасына 10 мг) бир убакта ичүүдө цетиризиндин экспозициясы 40%га көбөйгөн, ал эми ритонавирдин экспозициясы бир аз өзгөргөн (11%). Макролиддер же кетоконазол менен бирге колдонуу ЭКГда ишенимдүү өзгөрүүлөрдү пайда кылган эмес. Бир катар учурларда левоецетиризинди алкоголь же БНСке басуучу таасир көрсөтүүчү дары препараттары менен бир убакта колдонууда алардын БНСке таасири күчөшү мүмкүн, бирок рацемат цетиризин алкогольдун таасирин күчөткөнү далилденген эмес.

Монтелукаст.

Монтелукастты колко астмасын жана/же аллергиялык ринитти алдын алуу жана узакка дарылоо үчүн салттуу колдонулуучу башка дары каражаттары менен бирге дайындоого болот. Монтелукасттын сунушталган дарылык дозасы төмөнкү препараттардын фармакокинетикасына клиникалык маанилүү таасир көрсөтпөйт: теофиллиндин, преднизондун, преднизолондун, пероралдуу контрацептивдерге (этинилэстрадиол/норэтистерон 35/1), терфенадиндин, дигоксиндин жана варфариндин. Фенобарбиталды бир убакта ичүүдө AUC мааниси (болжолдуу 40%га) төмөндөйт, бирок монтелукасттын дозалоо режимин тууралоо талап кылынбайт. Эгерде монтелукаст фенитоин, фенобарбитал жана рифампицин сыяктуу CYP3A4 изоферментин индуцирлөөчү препараттар менен бир убакта дайындалса, монтелукаст CYP3A4 изоферменти менен зат алмашкандыктан, этияттыкты сактоо керек. Бирок монтелукасттын дозасын өзгөртүү талап кылынбайт. *In vitro* изилдөөлөр монтелукаст CYP2C8 изоферментинин потенциалдуу басаңдаткычы болуп эсептелгенин көрсөткөн, бирок монтелукастты жана росиглитазонду (медициналык препараттардын өкүлүнүн алдын ала субстраты, биринчи CYP2C8 изоферменти менен зат алмашат) кошкон препарат — препарат өз ара таасирин клиникалык изилдөөлөрдүн маалыматтары монтелукасттын дозасы *in vivo* CYP2C8 изоферментин басаңдатпаганын көрсөткөн. Демек, монтелукаст бул фермент (мисалы, паклитаксел, росиглитазон жана репаглинид) менен зат алмашуучу препараттардын зат алмашуусуна байкаларлык таасир көрсөтпөйт. Гемфиброзил (CYP2C8 жана 2C9 басаңдаткычы) монтелукасттын системалуу таасирине таасирин 4,4 эсеге жогорулатат. Бирок гемфиброзилдин монтелукасттын системалуу таасирине таасири 10 мг жактырылган дозадан ашкан дозаларда монтелукастты колдонууда коопсуздугу боюнча маалыматтардын негизинде клиникалык маанилүү деп эсептелбейт. Ошондуктан гемфиброзил менен бирге ичүүдө монтелукасттын дозасын тууралоо талап кылынбайт. Гемфиброзил жана монтелукаст менен бирге CYP3A4 күчтүү басаңдаткыч итраконазол менен бирге ичүү монтелукасттын системалуу таасирине таасиринин кошумча жогорулашына алып келген.

Өзгөчө көрсөтмөлөр:

Бейтаптарга астманын курч приступтарын дарылоо үчүн монтелукастты жана левоцетиризинди камтыган бул айкалышкан препаратты колдонуу сунушталбайт жана мындай учурлар үчүн дайыма өзүнүн жанында ылайыктуу шашылыш дарылоонун препараттарын даяр алып жүрүү керек. Приступ болушунда бейтаптар дароо дарыгерге кайрылуулары керек. Монтелукастты чукул ингаляциялык же оралдык кортикостероидге алмаштыруу сунушталбайт. Ацетилсалицил кислотасына жана башка стероиддик эмес сезгенүүгө каршы препараттарга (ССКП) тастыкталган аллергиясы бар бейтаптар монтелукаст менен дарылануу мезгилинде бул препараттарды кабыл албашы керек, себеби ал, аллергиялык колко астмасы бар бейтаптарда дем алуу функциясын жакшыртса да, ССКП пайда болгон бронхоконстрикцияны толук токтото албайт.

Монтелукастты кабыл алган бейтаптарда психоневрологиялык бузулуулар сүрөттөлгөн. Бул симптомдор башка факторлордон пайда болушу мүмкүндүгүн эске алып, алардын монтелукастты ичүү менен байланышы белгисиз. Дарыгерге бейтаптар жана/же алардын ата-энелери/кам көрүүчүлөрү менен бул жагымсыз көрүнүштөрдү талкуулоо зарыл. Бейтаптарга жана/же алардын ата-энелерине/кам көрүүчүлөргө ушуга окшогон симптомдор пайда болгон учурда бул тууралуу дарылаган дарыгерге билдирүү керек экендигин түшүндүрүү зарыл.

Айкалышкан Лесон препараты активдүү эмес компонент катары лактозаны камтыйт, ошондуктан сейрек тукум кууган галактозага көтөрүмсүздүк, Лаппа лактаза жетишсиздиги же глюкоза жана галактоза мальабсорбциясы синдрому көйгөйлөрү бар бейтаптарга бул каражатты кабыл алуу сунушталбайт. Алкоголь менен бир убакта колдонууда этияттыкты сактоо талап кылынат.

Унаа каражатын айдоо жана механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө таасири:

Лесон препаратын ичүүдө уйкусуроо өрчүшү мүмкүн, муну унаа каражаттарын башкаруу же механизмдер менен иштөө зарылдыгында эске алуу керек. Препаратты ичкен мезгилде көңүл буруунун жогору концентрациясын жана психомотордук реакцияларды талап кылган ишмердиктин потенциалдуу кооптуу түрлөрү менен алектенүүдөн кармануу максатка ылайыктуу.

Чыгаруу формасы:

Алу-Алу блистерде жука чел кабык менен капталган 10 таблеткадан.

2 блистер медицинада колдонуу боюнча нускамасы менен бирге картон кутуда.

Сактоо шарты:

Кургак, жарык тийбеген жерде 25°C дан жогору эмес аба табында сакталат.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Жарактуулук мөөнөтү:

3 жыл. Жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин колдонууга болбойт.

Берүү шарты:

Дарыгердин рецепти боюнча.

Соода маркасынын жана каттоо күбөлүгүнүн ээси:

Spey Medical Ltd.

Lynton House, 7-12 Tavistock Square,
London, WC1H 9LT, UK (Улуу Британия)

Ондүрүүчү:

Ravian Life Science Pvt. Ltd.

Plot No. 34, Sector-8A, IIE, SIDCUL,
Haridwar, Uttarakhand, India (Индия)

**Кыргыз Республикасынын аймагында керектөөчүлөрдөн продукциянын (товардын)
сапаты боюнча арыз доолорду кабыл алуучу уюм:**

«Aman Pharm» (Аман Фарм) ЖЧК, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Шооруков
көчөсү, 36.

Тел.: (0312) 560466, E-mail: aman.pharm12@gmail.com